内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·支气管扩张症

异质性疾病-指由遗传引发,但无法直接明确遗传发病机制的一类疾病

（性感认识：痰盂）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

复习《病理学》

管壁破坏,肉芽组织修复

1.支扩是支气管管腔持久性扩张、伴**管壁纤维性增厚**的慢性疾病（不能忽略管壁纤维化）

VS 特发性肺纤维化 胶原纤维收缩牵拉支气管扩张(临时)但无管壁纤维化

2.病因：**支气管肺炎如麻疹或百日咳（最主要）**、慢支炎、肺结核等

与干性支扩有关

3.发病机制 ①从里面撑大 ②从气道外面拉大 ③支气管失去支撑结构(关键)

③慢性感染特别是**反复化脓性炎如支气管肺炎** **→破坏支气管管壁结构**（软骨、弹力纤维、平滑肌等）	**支气管失去支撑结构（最主要）** 管壁弹性减弱
②支气管周围的肺组织因慢性炎症发生纤维化 （形成大量纤维组织）支扩可为限制性通气障碍	胶原纤维牵拉支气管 可达正常的4倍
① 咳嗽→支气管管腔内的压力↑	跨壁压↑→气道口径被动扩大

支扩可以是阻塞性通气功能障碍(痰液堵),也可以是限制性通气功能障碍

一、支扩的诱发因素

支扩诱发因素多选题一般都是全选

感染、免疫异常如白血病/风湿系统疾病/炎症性肠病、**阻塞**、α-抗胰蛋白酶缺乏、黄甲综合征、PCD/原发性纤毛不动征、Kartagener 征

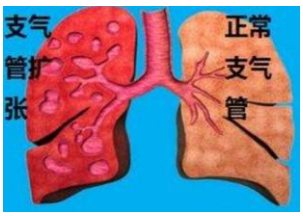
阻塞不是支扩病因,但是是诱发因素

小凯笔记自行整理

与α-抗胰蛋白酶缺乏有关的:
①全腺泡型肺气肿
②支扩
③肝硬化遗传因素

二、好发部位

支扩**好发于左肺下叶**；干性支扩好发于上叶尖后段（与肺结核有关）





给自己做天然引流,痰液不易积聚,不易出现大量咳浓痰的表现

下叶：痰不容易出来 下叶是规律 特殊:结核、结节病好发于上叶

左肺下叶有心脏压迫：痰不容易出来

右主支气管粗短陡：左侧痰液不容易出来 易存菌

右边更容易吸入,也更容易出来

三、临床表现

COPD一般不专门强调大量脓痰

1.长期咳嗽、咳**大量脓痰**（痰盂），湿啰音和干啰音尤其**固定持久的湿啰音**

液体 脓痰阻塞 扩张部位痰液积聚固定

管壁血管被破坏

2.支扩**多有咯血和杵状指** VS间质性肺疾病:杵状指

呼吸系统中咯血明显的:
①支扩
②肺结核
③肺癌

①50-70%患者可咯血，咯血量与疾病严重程度**不**完全相关 e.g 血量大把支气管堵死,咯血量少,但不代表病情轻

②干性支扩以反复咯血为唯一症状

③长期咯血→贫血→机体代偿增加回心血量→左心前负荷增加→左心扩大→相对性二闭→**心尖部收缩期杂音**

"门框变大"

携氧能力↓

呼吸系统、血液系统中出现心尖部收缩期杂音,选项中就会拿循环系统疾病做干扰

3.支扩可继发急性肺脓肿